

DERMATOLOGIE & ENDOCRINOLOGIE

Glandes Endocrines & Revêtement Cutané – Fiches QE Haute Fréquence – Version 1

Cross-match : 550 QEs officielles (2019 → 2026 (11 sessions)) × Cours AIO Dermato + Endocrino 2026 · Corrections officielles e-qe.online

Endocrino : Pr Elmghari · Pr Ansari · Pr Baizri – Dermato : Pr Bouhamidi · Pr Amal · Pr Aboudourib · Pr Hocar – FMPM 2025-26

PARTIE 1 – CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 550 QEs (11 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Diabète	89 Q	Pr. Elmghari
2	Adénome hypophysaire	65 Q	Pr. Ansari
3	IST (syphilis, VIH, écoulement, ulcération)	46 Q	Pr. Bouhamidi
4	Pathologie thyroïdienne & nodule	44 Q	Pr. Baizri
5	Questions transversales (diagnostic différentiel)	41 Q	– (transversal dermato)
6	Sd de Cushing & insuffisance surrénalienne	34 Q	Pr. Ansari
7	Dermatoses bulleuses	30 Q	Pr. Aboudourib
8	Infections cutanées virales (HSV/VZV/HPV/molluscum)	28 Q	Pr. Hocar
9	Cancers cutanés & mélanome	25 Q	Pr. Amal
10	Dermatoses bactériennes	22 Q	Pr. Hocar
11	Mycoses superficielles	21 Q	Pr. Hocar
12	Nutrition clinique	21 Q	Pr. Baizri
13	Obésité	16 Q	Pr. Baizri
14	Toxidermies médicamenteuses	13 Q	Pr. Bouhamidi
15	Eczéma (dermatite atopique + contact)	12 Q	Pr. Hocar
16	Prurit	9 Q	Pr. Aboudourib
17	Acné	8 Q	Pr. Amal
18	Ectoparasitoses & teignes du cuir chevelu	6 Q	Pr. Hocar
19	Erythème noueux	4 Q	Pr. Aboudourib
20	Tuberculose cutanée	3 Q	Pr. Aboudourib
21	Psoriasis	3 Q	Pr. Amal

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
22	Urticaire	2 Q	Pr. Bouhamidi
23	Lepre	2 Q	Pr. Aboudourib

PARTIE 2 – MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 11 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'examen
Diabète	89	8.09	16.2%
Adénome hypophysaire	65	5.91	11.8%
IST (syphilis, VIH, écoulement, ulcération)	46	4.18	8.4%
Pathologie thyroïdienne & nodule	44	4.00	8.0%
Questions transversales (diagnostic différentiel)	41	3.73	7.5%
Sd de Cushing & insuffisance surrénalienne	34	3.09	6.2%
Dermatoses bulleuses	30	2.73	5.5%
Infections cutanées virales (HSV/VZV/HPV/molluscum)	28	2.55	5.1%
Cancers cutanés & mélanome	25	2.27	4.5%
Dermatoses bactériennes	22	2.00	4.0%
Mycoses superficielles	21	1.91	3.8%
Nutrition clinique	21	1.91	3.8%
Obésité	16	1.45	2.9%
Toxidermies médicamenteuses	13	1.18	2.4%
Eczéma (dermatite atopique + contact)	12	1.09	2.2%
Prurit	9	0.82	1.6%
Acné	8	0.73	1.5%
Ectoparasitoses & teignes du cuir chevelu	6	0.55	1.1%
Erythème noueux	4	0.36	0.7%
Tuberculose cutanée	3	0.27	0.5%
Psoriasis	3	0.27	0.5%
Urticaire	2	0.18	0.4%
Lèpre	2	0.18	0.4%
TOTAL des leçons au programme (hors HTA endocrinienne)	544 Q	49.45	98.9%

PARTIE 3 – QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (▲) / source (📖) / lien cours (🔗) / citations (📌)

[RANG 1] DIABETE

Pr. Elmghari • ~8.09 Q/examen – 16% de CHAQUE examen, la leçon n°1

📖📖 Ref : SFD 2023-24 • CEEDMM • recomedicales.fr (diabete type 1 / type 2)

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel](#) 🔗

Criteres du diagnostic POSITIF de diabete :

- Glycemie a jeun (GAJ) veineuse $\geq 1,26$ g/l
- Glycemie aleatoire / post-prandiale ≥ 2 g/l (+ signes)
- HbA1c $\geq 6,5$ %
- ▲ ▲ GAJ $\geq 0,92$ g/l = seuil du diabete GESTATIONNEL, pas du diabete
- ▲ ▲ HbA1c $\geq 5,7$ % seule = prediabete
- ▲ ▲ Cetonurie / glycosurie isolees $\neq$ critere diagnostique

📌 Vu : N2019, N2020, N2022, Nov2024, N2025 (≈chaque session)

Etats PREDIABETIQUES – les 3 seuils :

- Hyperglycemie moderee a jeun (HMJ) : GAJ 1,10-1,25 g/l
- Intolerance au glucose : glycemie 2h post-HGPO 75g entre 1,40 et 1,99 g/l
- HbA1c entre 5,7 et 6,4 %
- ▲ ▲ Cas type : GAJ 1,24 + HbA1c 6,2 % $\rightarrow$ HMJ (GAJ $<1,26$ ET HbA1c $<6,5$)
- ▲ ▲ Glycemie post-prandiale 1,69 g/l $\rightarrow$ intolerance au glucose, pas diabete

📌 Vu : N2020, N2024, R2024, N2025 (cas de classification repetes)

L'HbA1c (hemoglobine glyquee) :

- Index valide, reflète la moyenne glycemique des 2-3 derniers mois
- Basee sur la glycation des proteines et de l'hémoglobine
- Exprimee en % ; dosee tous les 3 mois
- -1 point d'HbA1c $\approx$ -16 % de risque d'infarctus du myocarde
- ▲ ▲ N'est pas exprimee en g/l ni $\mu\text{g/dl}$
- ▲ ▲ Ne se dose pas chaque semaine

📌 Vu : N2019, N2026

L'effet incretine :

- Concerne 2 peptides intestinaux : GLP-1 et GIP
- Implique dans la physiopathologie du DT2
- Explique la difference de secretion d'insuline glucose oral vs IV
- Base des nouveaux traitements (analogues GLP-1, gliptines)
- ▲ ▲ N'explique pas les hypoglycemies severes
- ▲ ▲ Pas implique dans le DT1 ni le diabete insipide
- ▲ ▲ Ce ne sont pas la lipase/amylase

📌 Vu : R2019, N2019, R2021, N2024, N2026

L'insulinoresistance (DT2) :

- 1er mecanisme physiopathologique du DT2 (precede l'insulinopenie)

- Concerne MUSCLE squelettique, TISSU ADIPEUX et FOIE
- Peut donner un hyperinsulinisme et, au long cours, une apoptose des cellules beta
- Liee a l'obesite androide/viscerale
- *▲ ▲ Ne concerne pas cerveau, medullosurrenale, corticosurrenale, hypophyse*
- *▲ ▲ Au foie elle AUGMENTE la neoglucogenese (ne l'inhibe pas)*
- *▲ ▲ Obesite androide, pas gynoide*

 Vu : N2019, R2019, Nov2024, N2025, N2026

Diabete de type 1 :

- Atteinte AUTO-IMMUNE des cellules beta du pancreas ENDOCRINE → insulinocarence
- Avant 30 ans, pic a l'adolescence ; traite par INSULINE
- Debut aigu : acidocetose / syndrome cardinal (amaigrissement, appetit conserve)
- Anticorps : anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline, anti-ZnT8
- *▲ ▲ Pancreas ENDOCRINE, pas exocrine*
- *▲ ▲ Pas d'insulinoresistance ni d'obesite*
- *▲ ▲ Pas d'anti-TP0 / anti-DNA / anti-muscle lisse*

 Vu : N2019, R2021, Nov2024, N2026

Diabete cortico-induit :

- ≈ 2 % des diabetes ; depend de la dose ET de la duree de corticotherapie
- FdR : surcharge ponderale, ATCD familiaux de diabete
- Depiste par cycle de glycemies capillaires (8h-12h-14h/16h-20h)
- *▲ ▲ HbA1c seule INSUFFISANTE (diabete recent, post-prandial)*
- *▲ ▲ Pas de depistage par CLU*
- *▲ ▲ Pas 20 % des diabetes*

 Vu : N2019, R2019

Diabete gestationnel :

- Depiste par HGPO 75 g entre 24e et 28e SA
- FdR : age > 35 ans, ATCD personnel de diabete gestationnel
- Risque foetal : macrosomie + hypoglycemie neonatale
- Risque maternel : DT2 dans le post-partum
- *▲ ▲ Pas de depistage par HbA1c a la 8e SA*

 Vu : R2019, N2019

Etiologies de diabete SECONDAIRE / iatrogene :

- Pancreatiques : pancreatite, cancer/pancreatectomie
- Endocriniennes : acromegalie, Cushing/hypercorticisme, pheochromocytome
- Iatrogenes : corticoides, antiretroviraux, psychotropes, interferon alpha
- *▲ ▲ Maladie d'Addison N'EST PAS une cause (→ hypoglycemie)*
- *▲ ▲ Insuffisance cardiaque n'est pas une cause*
- *▲ ▲ Les sulfamides TRAITENT le diabete*

 Vu : R2021, N2025, N2026

Hyperglycemie de stress vs diabete revele (cas SCA/IDM) :

- Glycemie elevee a l'admission d'un evenement aigu chez non-diabetique

- Bilan : GAJ + HbA1c ; reevaluer a distance
- Si normalisation → stress/HMJ/IGT ; si HbA1c $\geq 6,5$ % ou persistance → diabete
- *▲ ▲ Une glycemie a 2,84 g/l a l'admission peut etre un DT2 revele OU un stress (les deux)*

📁 Vu : N2019, N2021, N2022, N2024, N2026 (cas repete)

Retinopathie diabetique :

- Complication microangiopathique LA PLUS frequente
- Lesion CARACTERISTIQUE du stade proliferatif = NEOVAISSEAUX
- Non-proliferante : microanevrysmes, exsudats, nodules cotonneux, oedeme maculaire
- Depistage annuel (F0) ; traitement proliferatif = panphotocoagulation laser
- *▲ ▲ Aggravee par HTA, anticoagulants, grossesse*
- *▲ ▲ Reponse unique « stade proliferatif » = neovaisseaux*

📁 Vu : N2019, R2021, N2021, Nov2024

Pied diabetique – physiopathologie & types d'ulcere :

- Pathogenie = neuropathie + arteriopathie + microtraumatismes + infection
- Ulcere NEUROPATHIQUE : INDOLORE, zone d'hyperpression, hyperkeratose peripherique, pouls PRESENTS
- Ulcere ARTERITIQUE : DOULOUREUX, necrose, pouls ABSENTS
- Avant amputation : echo-doppler arteriel, radio (osteite), bilan infectieux, pus
- *▲ ▲ Retinopathie/nephropathie ne font pas partie de la pathogenie du pied*
- *▲ ▲ Hyperkeratose peripherique n'est pas un critere d'ulcere arteritique*

📁 Vu : N2020, N2024, R2024, Nov2024

Neuropathie diabetique peripherique :

- Anesthesie thermo-algique ; atteinte motrice → deformations du pied
- Depistage principal = test au monofilament (10 g)
- *▲ ▲ EMG / echo-doppler ne sont pas le depistage de 1re intention*

📁 Vu : N2020

Hypoglycemie (triade de Whipple & signes) :

- Triade de Whipple : glycemie $< 0,60$ g/l + signes neuroglycopeniques + correction au resucrage
- Signes NEUROGLYCOPENIQUES : diplopie, convulsions, confusion, troubles du comportement
- Causes chez le diabetique : surdosage insuline/sulfamides/glinides, insuffisance surrenale, effort intense
- Hypoglycemies organiques endocriniennes : insulinome, insuffisance surrenale/corticotrope
- *▲ ▲ Tremblements/sueurs/palpitations = ADRENERGIQUES, pas neuroglycopeniques*
- *▲ ▲ Pheochromocytome et hyperthyroidie ne donnent pas d'hypoglycemie organique*

📁 Vu : N2022

Suivi & objectifs :

- HbA1c trimestrielle ; objectif ≤ 7 % (glycemie pre-prandiale 0,80-1,20 g/l)

- Microalbuminurie annuelle (des le dg en DT2, apres 5 ans en DT1)
- Fond d'oeil annuel
- **▲ ▲ Pas d'ECG trimestriel systematique**

📖 Vu : R2021, N2021

[RANG 2] ADENOME HYPOPHYSAIRE

Pr. Ansari • ~5.91 Q/examen

📖 📖 Ref : SFE • CEEDMM – adenomes hypophysaires / hyperprolactinemie / acromegalie

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Imagerie & classification de taille :

- Examen de REFERENCE = IRM hypophysaire
- Microadenome < 10 mm ; Macroadenome ≥ 10 mm
- Adenome le PLUS frequent = prolactinome
- **▲ ▲ Pas radio de selle turcique, scanner cerebral, ni octreoscaner pour classer**
- **▲ ▲ « Picoadenome » n'existe pas**

📖 Vu : N2020, R2021, N2021, N2022, N2024

Syndrome tumoral selon l'extension :

- SUPRA-sellaire → compression du chiasma → anomalies du champ visuel ; cepheales (frontotemporales, retro-orbitaires par etirement du diaphragme sellaie)
- LATERO-sellaire → sinus caverneux → diplopie, strabisme, ophtalmoplegie (III, IV, VI)
- **▲ ▲ Diplopie/strabisme = sinus caverneux (laterosellaire), pas suprasellaire**
- **▲ ▲ La diplopie n'est pas constante dans le macroadenome**

📖 Vu : R2021, N2021, N2022, N2025, N2026

Hyperprolactinemie – diagnostic biologique :

- UN dosage de prolactinemie de base simple, a n'importe quelle heure
- Macroprolactinome : PRL souvent > 200 ng/ml (ex. 500 ng/ml + macroadenome)
- Hyperprolactinemie de DECONNEXION : macroadenome non secretant comprimant la tige → PRL modereement elevee
- **▲ ▲ Pas de test TRH, ni dosage stimule, ni 3 dosages repetes**
- **▲ ▲ Gros adenome + PRL peu elevee = deconnexion, pas prolactinome**

📖 Vu : N2020, R2024, Nov2024

Avant de retenir un adenome : eliminer une hyperprolactinemie secondaire :

- Medicaments (neuroleptiques, antidepressseurs, antiemetiques)
- Insuffisance renale ; hypothyroidie primaire ; grossesse ; stress
- **▲ ▲ Paracetamol, insuffisance cardiaque, insuffisance hepatocellulaire ne donnent pas d'hyperprolactinemie**

📖 Vu : N2024, N2026

Manifestations & gynecomastie :

- Femme : amenorrhée, galactorrhée, infertilité – Homme : dysfonction érectile, baisse de libido, gynécomastie, atrophie testiculaire
- Gynécomastie = insuffisance gonadotrope → balance oestrogènes/testostérone EN FAVEUR des oestrogènes
- Gynécomastie pathologique : hypogonadisme, homme adulte, galactorrhée associée
- **▲ ▲ Pas un effet DIRECT de la PRL sur le sein, ni un excès de testostérone**
- **▲ ▲ Physiologique : nouveau-né, puberté**

 Vu : N2020, R2021, N2025

Acromégalie (adénome somatotrope) – clinique & diagnostic :

- Syndrome dysmorphique facial, doigts boudinés, raucité de la voix, protubérance occipitale, cyphoscoliose, hépatomégalie
- Diagnostic = GH NON freinée sous HGPO + IGF-1 élevée
- Enfance + persistance = acrogigantisme
- Comorbidités : diabète, goitre, HTA, SAOS, cardiopathie, dyslipidémie, articulations
- **▲ ▲ Pas le test GHRH, point isolé de GH, ni hypoglycémie insulinaire**
- **▲ ▲ Bosse de bison = Cushing, pas acromégalie**

 Vu : R2021, N2021, N2024, R2024

Traitement selon le type – LE piège thérapeutique :

- Prolactinome (micro ET macro) : agonistes dopaminergiques en 1re intention (cabergoline, bromocriptine)
- Acromégalie : chirurgie trans-sphénoïdale + analogues de la somatostatine
- Chirurgie 1re intention : maladie de Cushing, acromégalie, macroadénome non fonctionnel COMPRESSIF
- Microadénome non sécrétant non compressif : surveillance
- **▲ ▲ Le prolactinome (même macro) ne relève PAS de la chirurgie 1re → traitement MÉDICAL**
- **▲ ▲ Pas de somatostatine pour le prolactinome ; pas d'agonistes dopa en 1re pour l'acromégalie**

 Vu : N2020, R2021, N2021, N2024, R2024, N2025, N2026

[RANG 3] IST – SYPHILIS, VIH, ÉCOULEMENT & ULCÉRATION GÉNITALE

Pr. Bouhamidi • ~4.18 Q/examen

  Ref : recomedicales.fr (syphilis, IST) • CMIT • OMS

 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Toute ulcération génitale aigue :

- Est une IST jusqu'à preuve du contraire ET une urgence diagnostique
- Bilan IST systématique (TPHA-VDRL, sérologie VIH...)
- **▲ ▲ Pas « toujours syphilitique » ni « bénigne »**

 Vu : N2026

Chancre syphilitique vs chancre mou :

- Chancre SYPHILITIQUE (*T. pallidum*) : UNIQUE, INDOLORE, INDURE, fond propre, incubation ≈ 3 sem (10-90 j)
- Chancre MOU (*H. ducreyi*) : DOULOUREUX, sale/purulent, mou, multiple, incubation courte (3-5 j)
- Traitement chancre mou : azithromycine 1 g PO ou ceftriaxone 250 mg IM ou ciprofloxacine 500 mg, dose unique
- ⚠ ⚠ Une ulceration douloureuse purulente = chancre mou, PAS syphilitique
- ⚠ ⚠ Parmi herpes/chancre mou/aphte/syphilis, seule la syphilis est typiquement INDOLORE

📖 Vu : N2019, N2022, R2024, N2025, N2026

Ulcerations genitales A REPETITION :

- Herpes genital, aphtose genitale, erytheme pigmente fixe bulleux (toxidermie)
- ⚠ ⚠ La syphilis (chancre) et le chancre mou ne RECIDIVENT pas a repetition

📖 Vu : N2020, R2021, Nov2024

Ecoulement uretral :

- Purulent, abondant, incubation courte (2-5 j) → uretrite GONOCOCCIQUE (*N. gonorrhoeae*)
- Clair/minime, incubation plus longue (7-15 j) → uretrite a chlamydia / mycoplasme (non gonococcique)
- Traitement gonococcie : ceftriaxone 500 mg IM + doxycycline 200 mg/j x 7 j (co-traiter chlamydia)
- Germes des uretrites : gonocoque, Chlamydia trachomatis, Trichomonas
- ⚠ ⚠ *Treponema pallidum* et *Candida* ne sont pas des germes d'uretrite

📖 Vu : R2021, R2024, N2024, N2025, N2026

Serologie syphilitique (VDRL / TPHA) :

- VDRL = non treponemique (Ag cardiolipidique non specifique), le VDRL quantitatif suit l'evolution/traitement
- TPHA = treponemique specifique
- VDRL- TPHA- : elimine la syphilis ; VDRL- TPHA+ : peut se voir en syphilis tertiaire/cicatrice
- VDRL+ TPHA+ asymptomatique = syphilis latente
- ⚠ ⚠ VDRL+ TPHA- = FAUX POSITIF (pas une syphilis latente) → chez la femme enceinte avec examen normal : rassurer (apres controle)
- ⚠ ⚠ Latente precoce (<1 an) : 1 injection benzathine penicilline 2,4 MU ; tardive : 3 injections hebdomadaires

📖 Vu : N2021, N2022, N2024, Nov2024

VIH – primo-infection & manifestations cutanees :

- Primo-infection : 2-3 sem post-exposition, exantheme maculo-papuleux/scarlatiniforme + enantheme + fièvre ± signes neurologiques
- Confirmation : charge virale VIH (Western blot encore negatif en fenetre)
- Manifestations cutanees : a TOUS les stades, parfois revelatrices, valeur pronostique
- Dermatoses faisant demander une serologie VIH : molluscum etendu, zona du sujet jeune, chancre, Kaposi

- **▲ ▲ L'exanthème n'est pas constant, n'est pas toujours prurigineux, n'épargne pas les muqueuses**
- **▲ ▲ Manifestations cutanées PAS toujours tardives ni toujours infectieuses**

📖 Vu : N2020, R2021, N2026

Ulcerations / lésions au stade SIDA :

- Ulcération périnéale/peri-anale chronique : herpès, carcinome épidermoïde, ulcération à CMV
- Papules perlées ombiliquées : molluscum contagiosum (étendu)
- Papules angiomateuses : maladie de Kaposi, angiomatose bacillaire, histoplasmosis
- **▲ ▲ Une ulcération chronique au stade SIDA n'est pas anodine : penser carcinome épidermoïde et CMV**

📖 Vu : N2021, N2022, R2024, N2024, N2025

Condylomes & HPV ano-génitaux :

- Bilan : sérologie VIH + TPHA-VDRL + frottis cervico-vaginal
- Traitement : électrocoagulation, podophyllotoxine, cryothérapie, imiquimod
- Le vaccin HPV est PREVENTIF (ne traite pas les lésions existantes)
- **▲ ▲ Le vaccin 16/18 ne guérit pas les condylomes déjà présents**

📖 Vu : N2021

[RANG 4] PATHOLOGIE THYROIDIENNE & NODULE

Pr. Baizri • ~4.00 Q/examen

📖 📖 Ref : SFE • CEEDMM • EU-TIRADS (nodule) • recomedicales.fr (hypo/hyperthyroïdie)

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Syndrome thyrotoxique & diagnostic de thyrotoxicose :

- Syndrome thyrotoxique = ensemble des manifestations cliniques d'une HYPERTHYROÏDIE, commun à toutes les étiologies
- Diagnostic biologique de 1^{re} intention = couple TSH/LT4 (puis TSH/LT3 si LT4 normale)
- Hyperthyroïdie PATENTE : TSH basse + LT4 (ou LT3) élevée
- Hyperthyroïdie FRUSTE : TSH basse, LT4 et LT3 normales
- **▲ ▲ Le syndrome thyrotoxique seul ne suffit pas à poser le diagnostic (biologie indispensable)**
- **▲ ▲ Les Ac anti-TPO ne sont pas le 1^{er} examen (étiologie après dg positif)**

📖 Vu : R2019, R2021, N2024, R2024, N2025, N2026

Manifestations cardio-vasculaires de l'hyperthyroïdie :

- Tachycardie sinusale permanente, palpitations de repos
- ACFA (arythmie complète par FA)
- Insuffisance cardiaque à DÉBIT ÉLEVÉ
- **▲ ▲ Pas de bradycardie, pas d'IC à FE basse, pas d'AOMI, pas de souffle diastolique**

📖 Vu : R2019, R2021

Maladie de Basedow & nodule chaud toxique :

- Basedow plus fréquente chez la FEMME ; diagnostic positif = Ac anti-RECEPTEURS de la TSH (TRAK)
- Aspect « Thyroid inferno » (hypervascularisation diffuse) au doppler = Basedow
- Nodule chaud toxique à la scintigraphie I123 = hyperfixation LOCALISEE avec EXTINCTION du reste du parenchyme
- 3 etiologies principales d'hyperthyroïdie : Basedow, nodule toxique, goitre multinodulaire toxique
- ⚠ ⚠ *Basedow : PAS le diagnostic par anti-TPO/anti-Tg (ce sont surtout Hashimoto)*
- ⚠ ⚠ *Pas plus fréquente chez le sujet âgé/enfant*
- ⚠ ⚠ *Cancer thyroïdien et thyroïdites ne sont pas dans le trio principal*

📖 Vu : N2021, N2024, R2024, Nov2024, N2025, N2026

Hypothyroïdie – généralités & clinique :

- Majoritairement d'origine PERIPHERIQUE ; plus fréquente chez la femme
- Clinique (patente) : frilosité, constipation, rauque voix, hypoacousie, macroglossie, ralentissement psychomoteur, prise de poids
- ⚠ ⚠ *N'est pas rare au Maroc*
- ⚠ ⚠ *Amaigrissement / diarrhée = signes d'HYPER, pas d'hypothyroïdie*

📖 Vu : R2019, N2019, R2021, N2020

Etiologies des hypothyroïdies PERIPHERIQUES :

- Thyroïdites auto-immunes (Hashimoto = 1^{re} cause auto-immune chez la femme), thyroïdite du post-partum
- Thyroïdectomie totale, irradiation cervico-thoracique
- Carence iodée, surcharge iodée
- ⚠ ⚠ *Le pan-hypopituitarisme est une cause CENTRALE, pas périphérique*
- ⚠ ⚠ *Basedow et goitre multinodulaire toxique = hyperthyroïdie*
- ⚠ ⚠ *Pas la « surcharge en zinc »*

📖 Vu : N2020, N2024, R2024, Nov2024, N2025, N2026

Nodule thyroïdien :

- Fréquent ; cancéreux dans ≈ 5 % des cas (majorité bénins)
- Bilan : échographie cervicale systématique + classification EU-TIRADS (imperative) + TSH
- Si TSH basse → scintigraphie ; cytoponction échoguidée : EU-TIRADS 5 >5 mm, EU-TIRADS 4 >10 mm, EU-TIRADS 3 >20 mm
- ⚠ ⚠ *Classification EU-TIRADS, PAS BIRADS (sein) ni Bethesda (= cytologie)*
- ⚠ ⚠ *Scintigraphie si TSH BASSE (pas si TSH élevée)*
- ⚠ ⚠ *Pas de chirurgie systématique sur la seule taille, quel que soit le TIRADS*

📖 Vu : N2019, N2020, N2021, Nov2024, N2025, N2026

[RANG 5] QUESTIONS TRANSVERSALES – DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DERMATO

– (transversal dermato) • ~3.73 Q/examen – questions integratives de raisonnement

📖 📖 Ref : CEDEF (College des Enseignants de Dermatologie) • recomedicales.fr

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Lesions VESICULEUSES (le piege du « sauf ») :

- Vesiculeuses : herpes, varicelle, zona, eczema, gale, dermatophytie (bordure), erytheme polymorphe
- ⚠️ ⚠️ *Molluscum contagiosum = PAPULE (non vesiculeux)*
- ⚠️ ⚠️ *Urticairre = papule oedemateuse (non vesiculeux)*

📖 Vu : N2019, N2020

Plaque erythemato-squameuse / squameuse du CUIR CHEVELU :

- DD : psoriasis, eczema (dermite seborrheique), teigne
- Prurit du cuir chevelu de l'enfant : pediculose (lentes), folliculite, dermite seborrheique, etat pityriasique
- ⚠️ ⚠️ *Pelade = alopecie NON squameuse ; urticairre ≠ squameux*

📖 Vu : R2019, N2020, N2021, R2021

Plaques erythemato-squameuses chroniques (coudes/genoux, >10 ans) = PSORIASIS :

- Diagnostic le plus probable ; evolution par poussees
- CAT chez un hypertendu : conseiller l'arret du tabac + dermocorticoides
- Psoriasis : traitement topique 1re intention = dermocorticoides + analogue de vitamine D (calcipotriol)
- ⚠️ ⚠️ *Ne pas arreter l'inhibiteur calcique (ne donne pas de psoriasis) ; ce sont les BB et IEC qui aggravent*
- ⚠️ ⚠️ *Pas de biopsie systematique (diagnostic clinique) ; pas de corticothérapie orale (risque de rebond)*

📖 Vu : N2020, N2022, N2024, Nov2024, R2024, N2026

Signes unguaux & autres semiologies transversales :

- Bande pigmentee unguale s'etendant au repli proximal (signe de Hutchinson) → MELANOME unguaal
- Pachyonychie (hyperkeratose sous-unguaale) : psoriasis, onychomycose
- Atteinte articulaire + dermatose : psoriasis, syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, gonococcie, erytheme nouveau
- ⚠️ ⚠️ *Hematome unguaal ne s'etend pas au repli et migre distalement*
- ⚠️ ⚠️ *Urticairre aigue ne donne pas d'atteinte articulaire*

📖 Vu : N2021, N2024

Urgences dermatologiques & risque de cecite :

- Erythrodermie (urgence) : dermatite atopique, psoriasis, toxidermie
- Risque de CECITE : syndrome de Lyell, Stevens-Johnson, erytheme polymorphe (majeur), pemphigoide cicatricielle
- ⚠️ ⚠️ *Impetigo bulleux et « erysipele generalise » ne sont pas des causes d'erythrodermie*
- ⚠️ ⚠️ *La gale ne donne pas de cecite*

📖 Vu : N2020, R2021

DD des plis & lésions infantiles classiques :

- Plis : erythrasma (brunâtre, Wood rouge corail) vs candidose (depôts blanchâtres, pustules satellites) vs dermatophytie vs psoriasis inverse
- Nourrisson + pustules palmo-plantaire + fratrie qui se gratte = gale
- Enfant + érosions labio-gingivales aiguës + fièvre + adénopathie = primo-infection herpétique
- Croûtes méléçériques péri-orificielles, apyréxie = impétigo
- ⚠ ⚠ « Depôts blanchâtres » des plis → candidose (pas erythrasma)

📖 Vu : R2019, N2021, N2024, Nov2024, N2025, N2026

[RANG 6] Sd DE CUSHING & INSUFFISANCE SURRENALIENNE

Pr. Ansari • ~3.09 Q/examen (23 + 11 fusionnées)

📖 Ref : SFE • CEEDMM – hypercorticisme / insuffisance surrénale

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

CONFIRMER l'hypercorticisme (= perte du rythme circadien & non-freinabilité)

:

- Cortisol libre urinaire (CLU) sur 24h + créatininurie associée
- Cortisol de minuit (salivaire ou plasmatique ; cathéter préalable si plasmatique)
- Freinage MINUTE à la dexaméthasone (1 mg) – non-freinage = positif
- ⚠ ⚠ Le cortisol de 8h SEUL ne confirme pas (rythme circadien) ; il sert à l'insuffisance surrénale
- ⚠ ⚠ CLU sur 24h (pas 12h) ; pas de natriurèse ni de dexaméthasone la veille du CLU

📖 Vu : R2019, N2019, N2020, N2026

LOCALISER après confirmation = dosage de l'ACTH plasmatique :

- ACTH élevée/normale-haute → ACTH-DEPENDANT : maladie de Cushing (adénome corticotrope) ou ACTH ectopique
- ACTH basse → ACTH-INDEPENDANT (surrénalien) → TDM surrénalienne
- ACTH-dépendant : IRM hypophysaire + TDM thoracique fines coupes + octreoscan
- ⚠ ⚠ L'ACTH aide à LOCALISER, il ne confirme pas l'hypercorticisme

📖 Vu : R2019, N2019, N2020, N2025, N2026

Causes ACTH-dépendantes vs ACTH-indépendantes :

- ACTH-DEPENDANTES : maladie de Cushing (adénome corticotrope, micro/macro), tumeur neuroendocrine ectopique sécrétant l'ACTH
- ACTH-INDEPENDANTES : adénome cortisolique, corticosurrénalome, hyperplasie nodulaire des surrénales
- ⚠ ⚠ Tumeur surrénalienne et ectopie sécrétant le CORTISOL ne sont pas ACTH-dépendantes
- ⚠ ⚠ Adénome cortisolique = surrénalien (indépendant), pas une maladie de Cushing

📖 Vu : R2019, N2019, N2024, N2026

Maladie de Cushing & signe distinctif clinique :

- Maladie de Cushing = ACTH-dependante, adenome corticotrope (micro/macro), signes d'hypercatabolisme
- Traitement 1re intention = exereses chirurgicales par voie TRANS-SPHENOIDALE
- La MELANODERMIE / hyperpigmentation (par excès d'ACTH/MSH) ne s'observe QUE dans l'hypercorticisme ACTH-dependant
- *▲ ▲ La maladie de Cushing ne se diagnostique pas par le cortisol de 8h*
- *▲ ▲ Absence de melanoderme → oriente vers une origine surrenalienne (indépendante)*

📖 Vu : R2019, N2019, N2022, N2025, N2026

Clinique de l'hypercorticisme & complications :

- Obésité facio-tronculaire, membres greles, vergetures pourpres larges, HTA, hirsutisme
- Complications : diabète, maladies cardio-vasculaires, atteinte rhumatologique (ostéoporose), respiratoire (SAOS), infections
- *▲ ▲ Pas de tremblements, ni myxoedème, ni fièvre chronique*
- *▲ ▲ La pancréatite ne fait pas partie des complications du Cushing*

📖 Vu : N2020, N2025, N2026

Cushing EXOGENE (iatrogène) :

- Cause la plus fréquente d'hypercorticisme ; tableau biologique OPPOSE à l'endogène (ACTH et cortisol BAS, axe freine)
- Peut se décompenser en insuffisance surrenale aiguë à l'arrêt brutal
- *▲ ▲ Tableau hormonal oppose : ce n'est pas une hypersecretion mais une freination de l'axe*

📖 Vu : N2025

Insuffisance surrenalienne – confirmation & tests :

- Insuffisance PERIPHERIQUE (Addison) : ACTH ELEVE + cortisolémie de 8h BASSE
- Si cortisol de 8h non franchement bas → test au Synacthène / hypoglycémie insulinique
- *▲ ▲ Le test de FREINAGE est pour le Cushing, pas pour l'insuffisance surrenale*

📖 Vu : R2019, N2019, N2020

Etiologies de l'insuffisance surrenale :

- Peripheriques (Addison) : auto-immune (1re cause, ex. avec DT1), tuberculose surrenalienne, hémorragie bilatérale, infiltration/métastases
- Centrales (déficit corticotrope) : micro/macroadenome, radiothérapie hypophysaire, nécrose hémorragique (Sheehan), traumatisme crânien grave
- *▲ ▲ L'adenome cortisolique cause un Cushing, pas une insuffisance*

📖 Vu : R2019, N2019, N2020

Clinique & substitution selon le niveau :

- ADDISON (peripherique) : melanoderme, appétence pour le sel, hyponatrémie + HYPERkaliémie ; substitution = hydrocortisone + FLUDROCORTISONE, régime NORMOSALE

- Deficit CORTICOTROPE (central) : pas de melanodermie, pas de deficit mineralocorticoide ; substitution = hydrocortisone SEULE
- Hydrocortisone orale quotidienne ; education (doublement des doses en cas de stress, ne jamais arreter)
- **▲ ▲ Addison : PAS de regime sans sel, PAS de potassium per os (deja hyperkaliemique), pas d'injection hebdomadaire**
- **▲ ▲ Deficit corticotrope : pas besoin de fludrocortisone (aldosterone preservee)**

 Vu : R2019, N2019, N2020

[RANG 7] DERMATOSES BULLEUSES

Pr. Aboudourib • ~2.73 Q/examen

  Ref : CEDEF – dermatoses bulleuses auto-immunes (pemphigus, pemphigoide, DH)

 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

PEMPHIGUS (vulgaire/profond) :

- Dermatose bulleuse auto-immune INTRA-epidermique ; bulles FLASQUES sur peau normale
- Atteinte MUQUEUSE frequente (erosions buccales/genitales, souvent revelatrices)
- Signe de Nikolsky POSITIF ; cellules ACANTHOLYTIQUES (cytodiagnostic de Tzanck)
- Auto-Ac anti-desmogleine (1/3) ; depots d'IgG a la surface des keratinocytes (IFD)
- **▲ ▲ Le pemphigus est INTRA-epidermique (pas sous-epidermique)**
- **▲ ▲ Auto-Ac anti-desmogleine, PAS anti-collagene VII (= EBA)**

 Vu : R2019, N2019, N2021, N2026

PEMPHIGOIDE BULLEUSE :

- Sujet AGE ; bulles TENDUES sur peau erythemateuse ; PRURIT intense ; lesions urticariennes
- RESPECTE habituellement les muqueuses ; signe de Nikolsky NEGATIF
- Bulle SOUS-epidermique ; hypereosinophilie ; depot lineaire d'IgG + C3 sur la membrane basale (IFD)
- Traitement 1re intention : DERMOCORTICOIDES tres forts (clobetasol) ± corticothérapie orale
- **▲ ▲ Pas de cellules acantholytiques (≠ pemphigus) ; pas d'antibiotiques anti-staph ni aciclovir**

 Vu : R2021, R2024, Nov2024, N2025, N2026

DERMATITE HERPETIFORME :

- Adolescent/adulte jeune ; vesicules prurigineuses groupees « en bouquet » sur les faces d'EXTENSION (coudes, genoux, fesses)
- Associee a la maladie coeliaque ; Nikolsky negatif ; depots GRANULEUX d'IgA (papilles dermiques, IFD)
- Traitement : Disulone (dapsone) + regime sans gluten
- **▲ ▲ Atteinte des faces d'extension, sans atteinte muqueuse**

📖 Vu : R2019, R2021, N2022

Epidermolyse bulleuse acquise (EBA) :

- Bulle sous-epidermique ; auto-Ac anti-COLLAGENE VII ; grains de milium + cicatrices atrophiques ; fragilite mecanique
- ⚠️ ⚠️ *Devant des bulles laissant des grains de milium sur les zones de friction → penser EBA*

📖 Vu : N2019, N2022

Signe de NIKOLSKY positif :

- Pemphigus ; syndrome de Lyell (NET) ; epidermolyse staphylococcique (SSSS)
- ⚠️ ⚠️ *NEGATIF dans pemphigoïde bulleuse, dermatite herpetiforme, dermatose a IgA lineaire*

📖 Vu : N2021, N2025, N2026

Confirmation diagnostique d'une dermatose bulleuse :

- Biopsie d'une bulle recente (histologie) + biopsie de peau PERI-lesionnelle pour IFD + recherche d'Ac circulants (IFI)
- ⚠️ ⚠️ *Pas les Ac antinucleaires, ni les IgE totales, ni les patch-tests, ni le Tzanck seul*

📖 Vu : N2024, Nov2024, N2026

[RANG 8] INFECTIONS CUTANÉES VIRALES (HSV / VZV / HPV / MOLLUSCUM)

Pr. Hocar • ~2.55 Q/examen

📖 📖 Ref : CEDEF – herpes, zona/varicelle, verrues, molluscum

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Primo-infection herpetique (gingivostomatite) :

- Le plus souvent HSV1, chez l'enfant ; asymptomatique dans ≈ 90 %, patente dans 10 % ; incubation ≈ 1 semaine ; souvent benigne
- Prise en charge nourrisson : aciclovir systemique si besoin chez l'enfant + traitement topique chez la mere
- ⚠️ ⚠️ *Inversion piege : « asymptomatique 10 % / patente 90 % » est FAUX*
- ⚠️ ⚠️ *Pas due a HSV2, incubation ≠ 2 mois*

📖 Vu : N2019, N2020, N2024, Nov2024, N2025

Traitement preventif (suppressif) de l'herpes :

- Indique si > 6 recurrences/an ; valaciclovir 500 mg/j pendant 6 a 12 mois
- ⚠️ ⚠️ *Les seuils « >3 genitales » ou « >2 orofaciales » sont faux ; non contre-indique chez la femme enceinte/nouveau-ne*

📖 Vu : N2019, N2024, Nov2024, R2024, N2025

Zona (reactivation VZV) :

- Eruption vesiculeuse METAMERIQUE, unilaterale, sur un territoire sensitif (ex. hemi-ceinture, douleur a type de brulure)
- Zona OPHTALMIQUE (V1) = urgence ophtalmologique

- Chez le sujet jeune ou immunodeprime (chimiotherapie, Hodgkin) → rechercher une infection VIH
- **▲ ▲ Devant un zona du sujet jeune : serologie VIH en priorite**

📖 Vu : R2019, N2020, N2024, Nov2024, N2025

Varicelle (primo-infection VZV) :

- Contagieuse ; eruption vesiculeuse d'ages differents ; BENIGNE chez l'enfant, SEVERE chez l'adulte/immunodeprime/femme enceinte
- Complications : pneumopathie varicelleuse, ataxie cerebelleuse, encephalite, surinfection bacterienne, syndrome de Reye (aspirine)
- Varicelle gravidique → syndrome de varicelle congenitale : microphthalmie, microcephalie, cicatrices depimees achromiques, hypoplasie de membre
- **▲ ▲ Due au VZV (pas HSV1, pas HPV) ; eviter l'aspirine (Reye)**

📖 Vu : N2019, R2019, R2021, N2024, Nov2024, N2025, N2026

Molluscum contagiosum (poxvirus) :

- Tumeur cutanee benigne virale ; plus frequent chez l'ENFANT ; papules perlees, fermes, ombiliquees (1-6 mm), possibles sur muqueuses
- **▲ ▲ N'atteint pas « essentiellement l'adulte immunocompetent » (forme etendue/adulte → penser immunodepression)**

📖 Vu : R2019, R2024, N2024, N2025

Verrues (HPV) :

- Verrues vulgaires : enfant, mains/avant-bras
- Myrmecie : verrue plantaire ENDOPHYTIQUE DOULOUREUSE (HPV1)
- **▲ ▲ La myrmecie n'est pas une verrue superficielle ni un durillon**

📖 Vu : R2019, N2024

[RANG 9] CANCERS CUTANES & MELANOME

Pr. Amal • ~2.27 Q/examen

📖 📖 Ref : CEDEF • INCa – carcinomes cutanes / melanome

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Carcinome BASOCELLULAIRE (CBC) – le stem le plus repete :

- Lesion nodulaire TRANSLUCIDE TELANGIECTASIQUE du visage/front/cuir chevelu evoluant depuis 2-3 ans → CBC
- Cancer cutane le plus frequent ; malignite LOCALE, ne metastase PAS ; zones photo-exposees ; traitement chirurgical
- Bilan d'extension : AUCUN
- **▲ ▲ Une lesion nodulaire translucide telangiectasique = CBC (pas carcinome epidermoide, pas melanome achromique)**

📖 Vu : N2020, N2022, R2024, N2024, N2026 (repete)

Carcinome EPIDERMOIDE (CE / spinocellulaire) :

- Lesion ULCERO-VEGETANTE (cuir chevelu, levre inferieure) evoluant 2 ans → CE
- Survient le plus souvent sur une lesion PRECANCEREUSE ; aspect ulcero-vegetant ; PEUT metastaser

- Confirmation : biopsie cutanee ; bilan d'extension : echographie abdominale + radio thorax
- **▲ ▲ Le CE ne respecte pas les muqueuses et DONNE des metastases ; traitement = chirurgie (pas essentiellement chimiotherapie)**

📖 Vu : N2019, N2021, R2024, N2024, N2025

Lesions PRECANCEREUSES & keratoses actiniques :

- Keratoses actiniques : taches rugueuses brunatres, zones photo-exposees, phototype clair (agriculteurs) → se transforment en CE ; traitement cryotherapie/5-FU/imiquimod
- Autres precancereuses : corne cutanee, leucoplasie (levre), maladie de Bowen, radiodermite, melanose de Dubreuilh
- **▲ ▲ Les keratoses actiniques se transforment en CARCINOME EPIDERMOIDE (pas CBC, pas melanome)**
- **▲ ▲ La keratose seborrheique est BENIGNE (non precancereuse)**

📖 Vu : N2020, R2021, N2026

MELANOME :

- Survient le plus souvent sur un naevus PRE-EXISTANT (ou de novo) ; malignite GENERALE (metastase)
- Au Maroc : siege le plus souvent au niveau PLANTAIRE (melanome acral) ; peut atteindre les ONGLES et le cuir chevelu
- Devant une macule pigmentee plantaire → eliminer en premier un melanome
- FdR : phototype clair, ATCD familial de melanome, naevus congenital geant, naevus multiples, expositions solaires
- **▲ ▲ Le melanome N'EST PAS a malignite locale (il metastase)**
- **▲ ▲ La prevention n'est pas d'enlever tous les naevus systematiquement (= photoprotection + surveillance ABCDE)**
- **▲ ▲ FdR : pas le tabac, pas l'HPV**

📖 Vu : N2019, R2021, N2021, N2022, N2024, Nov2024, N2026

[RANG 10] DERMATOSES BACTERIENNES

Pr. Hocar • ~2.00 Q/examen

📖 Ref : CEDEF – infections cutanees bacteriennes (staph/strepto)

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Folliculites / furoncle / anthrax (Staphylococcus aureus) :

- Folliculite superficielle : pustule centree par un poil + macule erythemateuse ; favorisee par dermocorticoides et obesite ; pas toujours d'ATB general
- Furoncle : folliculite profonde necrosante (bourbillon) ; traitement anti-staph (acide fusidique, penicilline M)
- Anthrax : agglomerat de furoncles (nuque/dos), chez le diabetique, avec fièvre/AEG
- Furoncle du VISAGE manipule → staphylococcie maligne de la face (urgence)
- **▲ ▲ Ne JAMAIS inciser/manipuler un furoncle centro-facial (risque de staphylococcie maligne)**

📖 Vu : R2019, N2019, R2021, N2024, N2026

Panaris :

- Infection peri-unguaale a Staphylococcus aureus ; peut se compliquer d'arthrite/osteite
- *⚠ ⚠ Ne siege pas « essentiellement au visage » et n'est pas du a un strepto ; n'est pas centre par une pustule folliculaire (≠ folliculite)*

📖 Vu : R2019, N2019

Impetigo :

- Contagieux, bacterien ; croutes MELICERIQUES peri-orificielles ; apyrexie, bon etat general (enfant)
- Impetigo bulleux : bulle superficielle (exfoliatine staphylococcique), nourrisson, fratrie atteinte
- Peut se compliquer de glomerulonephrite post-streptococcique (bandelette urinaire a 3 semaines)
- *⚠ ⚠ Devant des croutes melicériques chez l'enfant apyretique → impetigo (pas furoncle, pas eczema)*

📖 Vu : R2021, N2022

Erysipele (dermo-hypodermite, streptocoque A) :

- Placard rouge chaud douloureux bien limite de jambe, fièvre 38,5-40 °C, lymphangite, porte d'entree (intertrigo/plaie)
- Traitement : penicilline G IV 12-20 MU/j jusqu'a l'apyrexie puis relais oral ; si allergie aux betalactamines → macrolide
- Hospitalisation : fièvre >40/sepsis, polypnee, decollement bulleux etendu, signes de purpura/necrose, comorbidites (diabete), doute avec fasciite
- *⚠ ⚠ La CREPITATION n'existe JAMAIS dans l'erysipele simple (= gaz → fasciite necrosante)*
- *⚠ ⚠ Pas d'AINS (risque de fasciite necrosante), pas de corticoides*

📖 Vu : R2019, N2020, N2021, N2022

SSSS (epidermolyse staphylococcique aigue) :

- Enfant ; decollement diffus, signe de Nikolsky POSITIF, RESPECTE les muqueuses ; complique un foyer staph ; clivage sous-corne
- *⚠ ⚠ Respecte les muqueuses (≠ Lyell), pas de grains de milium*

📖 Vu : N2020

Autres : anite streptococcique & erythrasma :

- Anite/dermite peri-anale streptococcique (enfant) : erytheme bien limite ; ATB general 3 semaines ; bandelette urinaire a 3 semaines
- Erythrasma : Corynebacterium minutissimum, plis (aisselle/aîne) brunatres, fluorescence ROUGE CORAIL a la lampe de Wood, diabetique
- *⚠ ⚠ Erythrasma (depots absents) vs candidose des plis (depots blanchatres + pustules satellites)*

📖 Vu : N2024, N2026

[RANG 11] MYCOSES SUPERFICIELLES

📖 Ref : CEDEF – dermatophytoses, candidoses, pityriasis versicolor

📄 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Dermatophytes (generalites) :

- Champignons KERATINOPHILES → peau, poils (atteinte pilaire), ongles
- Dermatophytie de la peau glabre (herpes circine) : extension CENTRIFUGE, bordure vésiculeuse active, centre évolutif
- Intertrigo inter-orteil : 3e-4e espace ++, favorise par piscines, complique d'eczéma dyshidrosique et d'erysipele (porte d'entrée)
- ⚠️ ⚠️ Les dermatophytes ne donnent PAS de localisation viscérale ni muqueuse (= candida)

📖 Vu : N2020, N2022, R2021

Teignes du cuir chevelu :

- MICROSPORIQUE : Microsporum (canis zoophile...), GRANDES plaques alopeciques, peu nombreuses, fluorescence VERTE à la lampe de Wood
- TRICHOPHYTIQUE : Trichophyton anthropophile, PETITES plaques multiples, cheveux cassés à l'émergence, Wood NEGATIF
- FAVIQUE : T. schoenleinii, godet favique, alopecie CICATRICIELLE (définitive)
- Inflammatoire (kerion) : dermatophyte zoophile, possible fièvre, possible hors cuir chevelu ; les teignes tondantes guérissent à la puberté
- ⚠️ ⚠️ Wood VERT = microsporique ; Wood négatif = trichophytique
- ⚠️ ⚠️ La teigne favique ne guérit pas spontanément (alopecie cicatricielle)

📖 Vu : N2020, R2021, R2024, Nov2024, N2025, N2026

Traitement des teignes :

- Griseofulvine PO 20 mg/kg/j x 6-8 semaines (≈ 250 mg x2/j pour 25 kg) + soins locaux (keratolytiques + antifongiques locaux)
- Coupe des cheveux autour des plaques, désinfection bonnets/peignes, éviction scolaire, recherche d'animaux infectés (zoophile)
- ⚠️ ⚠️ Pas de pénicilline (infection fongique, pas bactérienne)

📖 Vu : N2020, R2021, N2024

Candidoses (Candida albicans) :

- Favorisées par : diabète, macération, prothèses dentaires, contraceptifs oraux, corticothérapie, antibiotiques
- Atteignent : muqueuses (muguet, vulvovaginite = IST possible), grands plis (intertrigo), ONGLES des MAINS, langue noire villosité
- ⚠️ ⚠️ Le candida ne donne PAS de teigne (= dermatophytes) ; ongles des mains (vs dermatophytes : pieds)

📖 Vu : N2020, R2021, N2022

Pityriasis versicolor & folliculite pityrosporique (Malassezia) :

- Pityriasis versicolor : Malassezia furfur, favorise par hypersudation + climat chaud/humide ; macules chamois/brunâtres/achromiques, fine desquamation
- Folliculite pityrosporique : papules/pustules folliculaires du dos/épaules (adulte d'âge moyen) ; traitement ANTIFONGIQUE
- ⚠️ ⚠️ Diagnostic par examen mycologique direct (PAS le Tzanck)
- ⚠️ ⚠️ Folliculite pityrosporique traitée par antifongiques (pas antibiotiques)

📖 Vu : R2021, N2024

Examen mycologique :

- Indispensable pour confirmer une dermatophytie ; AVANT tout antifongique
- Après fenetre therapeutique : 4 semaines (antifongiques locaux), 3 mois (terbinafine) ; peau glabre → prelever la BORDURE active
- ⚠️ ⚠️ Ne pas prelever le centre de la lesion sur peau glabre (= bordure active)

📖 Vu : R2021

[RANG 12] NUTRITION CLINIQUE

Pr. Baizri • ~1.91 Q/examen

📖 Ref : PNNS • recomedicales.fr – nutrition / equilibre alimentaire

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Macronutriments vs micronutriments :

- MACRONUTRIMENTS = glucides, lipides, proteines → seules sources d'energie du corps
- MICRONUTRIMENTS = vitamines (liposolubles + hydrosolubles) + oligo-elements + mineraux ; non energetiques ; leur carence peut causer une maladie
- ⚠️ ⚠️ Les macronutriments ne sont pas les vitamines/oligo-elements
- ⚠️ ⚠️ Les micronutriments ne sont pas une source d'energie

📖 Vu : N2020, R2021, N2024, Nov2024, N2025, N2026

Vitamines & valeurs caloriques :

- 13 vitamines au total ; LIPOSOLUBLES = A, D, E, K ; hydrosolubles = complexe B et C
- Valeurs caloriques : glucides 4 kcal/g, proteines 4 kcal/g, LIPIDES 9 kcal/g (10 g de lipides = 90 kcal)
- Exemple : 150 g glucides + 80 g protides + 100 g lipides = 1820 kcal
- ⚠️ ⚠️ La vitamine C est HYDROSOLUBLE (pas liposoluble) ; la K est liposoluble
- ⚠️ ⚠️ Apports proteiques conseilles ≈ 0,8-1 g/kg/j (pas 2 g/kg/j)

📖 Vu : R2019, N2019, N2020, R2021, N2021

Index glycémique (IG) & charge glycémique (CG) :

- IG a prendre en compte ; bas si < 55, eleve si > 70 ; varie chez une meme personne selon fibres/lipides/proteines du repas
- IG du pain blanc > pain complet/cereales ; glucides des legumineuses « meilleurs » (IG plus bas) que ceux du miel
- CHARGE glycémique = $IG \times (g \text{ de glucides}) / 100$; plus pertinente que l'IG ; basse ≤ 10, elevee ≥ 20 (ex. IG 60 % x 40 g = 24 → elevee)
- « Sucre » dans l'industrie alimentaire = saccharose
- ⚠️ ⚠️ IG 40/45/55 % = NON eleve ; un IG a 80 % est eleve
- ⚠️ ⚠️ Densite nutritionnelle FAIBLE + densite energetique ELEVEE = malbouffe (fritures, soda, sans legumes)

📖 Vu : R2019, N2019, N2020, R2021, N2021, N2022, N2024, Nov2024, N2025, N2026

[RANG 13] OBESITE

Pr. Baizri • ~1.45 Q/examen

📖 📖 Ref : OMS (IMC) • recomedicales.fr – obesite de l'adulte

🔗 Correction officielle Normal 2024 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Definition & classification IMC (OMS) :

- Obesite = excès de MASSE GRASSE avec conséquences nefastes pour la sante
- Surpoids 25-30 ; obesite moderee 30-35 ; severe 35-40 ; MORBIDE ≥ 40 (IMC 55 → morbide)
- Tour de taille = bon indicateur de l'obesite VISCERALE (androide ♀ > 80 cm, ♂ > 94 cm)
- ⚠️ ⚠️ L'IMC ne renseigne PAS sur le type androide/gynode (= tour de taille)

📖 Vu : R2019, N2024, R2024, Nov2024, N2025

Facteurs & causes secondaires :

- Facteurs : genetiques, troubles du comportement alimentaire, sedentarite, troubles emotionnels/psychologiques
- Obesites secondaires medicamenteuses : corticoides, neuroleptiques, antidépresseurs
- ⚠️ ⚠️ Rechercher une cause secondaire AVANT de conclure a une obesite essentielle

📖 Vu : N2024, R2024, Nov2024

Complications & bilan :

- Complications : prediabete, diabete, maladie coronaire, SAOS, HTA, dyslipidemie, atteinte articulaire (arthrose)
- Bilan systematique : HbA1c, bilan lipidique, recherche de SAOS, complications articulaires
- ⚠️ ⚠️ Arthrose (pas « polyarthrite ») ; pas de TDM abdominale systematique

📖 Vu : N2024, R2024, Nov2024

Traitement de 1re intention (obesite essentielle) :

- Correction des erreurs alimentaires + activite physique + soutien psychosocial + education therapeutique
- ⚠️ ⚠️ Pas de chirurgie en 1re intention ; pas de liposuccion/abdominoplastie (cosmetique, pas un traitement de l'obesite)

📖 Vu : N2024, R2024, Nov2024

[RANG 14] TOXIDERMIES MEDICAMENTEUSES

Pr. Bouhamidi • ~1.18 Q/examen

📖 📖 Ref : CEDEF • CRPV – toxidermies graves (NET/SJS/DRESS/PEAG)

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Syndrome de Lyell (NET – necrolyse epidermique toxique) :

- Toxidermie GRAVE ; decollement cutane > 30 % (Lyell) [SJS < 10 %, overlap 10-30 %]
- Signe de Nikolsky POSITIF ; febrile ; dermatose bulleuse ; erosions muqueuses (cheilite, conjonctivite, « decollement en linge mouille »)
- Peut se compliquer de CECITE (sequelles oculaires)
- *▲ ▲ N'est PAS photodistribue ; n'est pas une epidermolyse staphylococcique (= SSSS) ; n'epargne pas les muqueuses*
- *▲ ▲ Le « < 10 % » correspond au SJS, pas au Lyell*

📖 Vu : N2019, N2021, N2024, Nov2024, N2025

Erytheme pigmenté fixe (EPF) :

- SEULE toxidermie EXCLUSIVEMENT medicamenteuse ; recidive au MEME site
- *▲ ▲ Devant des ulcerations genitales a repetition d'origine medicamenteuse → EPF bulleux*

📖 Vu : N2019, N2024, R2024, Nov2024, N2025

Toxidermies GRAVES & risque de cecite :

- Graves : NET/Lyell, Stevens-Johnson, DRESS (syndrome d'hypersensibilite), PEAG (pustulose exanthematique aigue generalisee)
- Risque de cecite : Lyell et Stevens-Johnson
- *▲ ▲ Erytheme polymorphe MINEUR et simple photosensibilite ne sont pas des toxidermies graves*

📖 Vu : R2019, N2026

Ce qui n'est JAMAIS une toxidermie :

- La dermatite atopique (constitutionnelle) n'est jamais un accident cutane medicamenteux
- *▲ ▲ Psoriasis, eczema, EPF, erytheme polymorphe PEUVENT etre declenches/lies a un medicament – pas la dermatite atopique*

📖 Vu : N2022

[RANG 15] ECZEMA (DERMATITE ATOPIQUE + ECZEMA DE CONTACT)

Pr. Hocar • ~1.09 Q/examen (9 + 3 fusionnees)

📖 📖 Ref : CEDEF – dermatite atopique / eczema de contact

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Dermatite atopique – clinique & topographie par age :

- Evolue par POUSSEES ; peut s'etendre sur toute la surface ; peut se compliquer de surinfection a HSV (Kaposi-Juliusberg)
- NOURRISSON : zones CONVEXES (joues, front, cuir chevelu, faces d'extension) – ENFANT (>2 ans, ex. 4 ans) : plis de FLEXION
- Diagnostic : atonie personnelle/familiale (asthme, rhinoconjonctivite allergique), lesions similaires des zones convexes du visage
- *▲ ▲ Ne disparaît pas TOUJOURS a l'age adulte ; epargne la region perineo-fessiere*
- *▲ ▲ Pas d'argument : ATCD de psoriasis, symptomatologie articulaire*

📖 Vu : N2019, N2024, R2024, Nov2024, N2025

Dermatite atopique – traitement :

- Base OBLIGATOIRE : nettoyant surgras + emollients
- Poussees : dermocorticoides (activite moderee pour le visage/nourrisson)
- ⚠️ ⚠️ Les dermocorticoides ne sont PAS interdits chez le nourrisson ; la vaccination n'est pas contre-indiquee

📖 Vu : R2024, Nov2024, N2025, N2026

Eczema de contact :

- Mecanisme = hypersensibilite RETARDEE de TYPE IV
- Allergene metallique le plus frequent = NICKEL (pulpite des doigts, bijoux fantaisie) ; diagnostic = patch-tests
- ⚠️ ⚠️ Ce n'est PAS une allergie IgE de type I, ni un depot d'immuns complexes, ni une action toxique directe, ni phototoxique

📖 Vu : N2022, N2026

[RANG 16] PRURIT

Pr. Aboudourib • ~0.82 Q/examen

📖📖 Ref : CEDEF – prurit (demarche etiologique)

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Traitement symptomatique du prurit :

- PHOTOTHERAPIE (UVB) ± antihistaminiques per os (prurit chronique)
- ⚠️ ⚠️ Pas d'hydrocortisone injectable, pas d'adrenaline SC, pas de derives cholinergiques, pas d'histamine PO (l'histamine donne le prurit)

📖 Vu : N2019, N2024, R2024, Nov2024, N2025

Bilan d'un prurit generalise sans dermatose :

- Bilan minimal : VS, creatinine, NFS, bilan hepatique, TSH, glycemie, calcemie (recherche d'une cause systemique)
- ⚠️ ⚠️ Pas d'echographie cutanee ni de prelevement mycologique des ongles en 1re intention

📖 Vu : R2019, N2020

Orientations etiologiques cles :

- Prurit + asthenie + amaigrissement chez un sujet jeune → lymphome de Hodgkin (prurit paraneoplasique)
- Prurit + bulles tendues sur peau erythemateuse chez le sujet age → pemphigoide bulleuse
- ⚠️ ⚠️ Un prurit chronique inexplique doit faire chercher une cause systemique/hematologique

📖 Vu : R2021, N2026

[RANG 17] ACNE

Pr. Amal • ~0.73 Q/examen

Acne RETENTIONNELLE (microkystes/comedons, aspect luisant, sans inflammation) :

- Traitement = RETINOIDE TOPIQUE SEUL (adapalene)
- ⚠️ ⚠️ *Pas de cyclines ni d'antibiotique local pour une acne purement retentionnelle*

📄 Vu : R2021, N2022, R2024, N2025, N2026 (reponse repete)

Acne INFLAMMATOIRE / MIXTE :

- Papulo-pustuleuse diffuse : cyclines PO + retinoide topique (ou cyclines + peroxyde de benzoyle + retinoide topique)
- Mixte a predominance inflammatoire : cyclines PO + peroxyde de benzoyle + retinoide topique
- Cyclines : minimum 3 mois, JAMAIS en monotherapie (toujours + retinoide topique)
- ⚠️ ⚠️ *Pas d'antibiotherapie locale en monotherapie (resistances) ; cyclines pas « 6 mois » en routine*
- ⚠️ ⚠️ *Isotretinoine PO reservee aux formes severes/nodulokystiques ou resistantes*

📄 Vu : N2021, Nov2024, N2024

[RANG 18] ECTOPARASITOSE & TEIGNES DU CUIR CHEVELU

Pr. Hocar • ~0.55 Q/examen

Gale (Sarcoptes scabiei) :

- Prurit a recrudescence nocturne, contagé familial (fratrie qui se gratte), sillons + nodules scabieus ; nourrisson : pustules palmo-plantaire
- Traitement (benzoate de benzyle) : application le SOIR, laisser poser, traiter TOUT l'entourage, désinfecter linge/literie
- « Gale des gens propres » : prurigineuse, pauci-lésionnelle (diagnostic difficile)
- ⚠️ ⚠️ *La gale EST contagieuse (la « gale des gens propres » n'est pas non contagieuse)*
- ⚠️ ⚠️ *Eviter l'application le matin ; chez le nourrisson, soins particuliers (visage/cuir chevelu inclus)*

📄 Vu : R2019, N2020, N2021

Pediculose du cuir chevelu (poux) :

- Prurit du cuir chevelu/nuque + lentes (petits corps gris ovoïdes fixes latéralement au cheveu) + folliculite + adénopathies cervicales
- Pediculus pubis (morpion) : peut être une IST
- ⚠️ ⚠️ *Devant un prurit du cuir chevelu de l'enfant avec lentes → pediculose*

📄 Vu : R2019, N2020, N2021

Teignes (rappel – voir aussi Mycoses) :

- Microsporique : grandes plaques, Wood VERT ; trichophytique : petites plaques multiples, Wood negatif
- Folliculite pityrosporique : papulo-pustules folliculaires du dos/epaules
- **▲ ▲ Les teignes sont des dermatophytoses (traitement = griseofulvine, pas antibiotique)**

📖 Vu : N2021, N2022, N2024

[RANG 19] ERYTHEME NOUEUX

Pr. Aboudourib • ~0.36 Q/examen

📖 📖 Ref : CEDEF – erytheme noueux (demarche etiologique)

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Semilogie :

- Noueures DOULOUREUSES, BILATERALES, face ANTERIEURE des jambes, SANS ulceration ni necrose (dermo-hypodermite)
- **▲ ▲ Pas de bulles a Nikolsky+ (= bulleuse), pas de nodules ulceres chroniques, pas de papules purpuriques necrotiques**

📖 Vu : N2026

Etiologies & syndrome de Lofgren :

- Etiologies : infection streptococcique (post-strep), SARCOIDOSE, tuberculose (primo-infection), MICI (Crohn, RCH), medicaments, Yersinia, Behcet
- Syndrome de LOFGREN = erytheme noueux + adenopathies hilaires/mediastinales bilaterales + arthralgies + fièvre → sarcoidose aigue
- **▲ ▲ Ni syphilis secondaire, ni syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter, ni psoriasis**

📖 Vu : N2019, N2022, R2024, N2025

[RANG 20] TUBERCULOSE CUTANEE

Pr. Aboudourib • ~0.27 Q/examen

📖 📖 Ref : CEDEF • PNLAT Maroc – tuberculose cutanee

🔗 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Generalites :

- Evolution chronique et lente ; certaines formes mutilantes/cicatricielles ; l'immunodepression favorise les formes etendues/disseminees
- **▲ ▲ N'est pas TOUJOURS secondaire a une atteinte pulmonaire active ; la guerison spontanee n'est pas frequente**

📖 Vu : N2026

Formes cliniques :

- Tuberculose verruqueuse : contamination professionnelle/accidentelle ou auto-inoculation ; IDR fortement positive

- Gomme tuberculeuse : immunodeprime/dénutri, membres inférieurs, abcès qui se ramollit puis s'ulcère (laisse une cicatrice)
- **▲ ▲ Traitement = antibacillaires standard (phase intensive de 4 antibacillaires 2 mois puis 2 antibacillaires) – « 4 antibacillaires pendant 6 mois » est inexact**

 Vu : N2019, N2021

[RANG 21] PSORIASIS

Pr. Amal • ~0.27 Q/examen

  Ref : CEDEF • recomedicales.fr – psoriasis

 Correction officielle normal 2025 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Medicaments AGGRAVANTS :

- Beta-bloquants, antipaludeens de synthèse, IEC, lithium, AINS
- **▲ ▲ Le methotrexate et la ciclosporine TRAITENT le psoriasis (ne l'aggravent pas) ; les inhibiteurs calciques ne l'aggravent pas**

 Vu : N2021, N2024

Indications du traitement SYSTEMIQUE :

- Atteinte étendue (> 10 % surface corporelle), rhumatisme psoriasique, psoriasis pustuleux généralisé, erythrodermie, retentissement majeur
- Topique 1^{re} intention : dermocorticoïdes + analogue de vitamine D
- **▲ ▲ Le seuil n'est pas « > 3 % de surface » (≈ 10 %)**

 Vu : N2025

[RANG 22] URTICAIRE

Pr. Bouhamidi • ~0.18 Q/examen

  Ref : CEDEF – urticaire aiguë/chronique

 Correction officielle normal 2026 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Urticaire superficielle :

- Papules OEDEMEATEUSES FUGACES (< 24 h), PRURIT fréquent, oedème dermique, SANS cicatrice résiduelle
- **▲ ▲ Des lésions > 48 h ou laissant une cicatrice → vascularite urticarienne (pas une urticaire simple)**

 Vu : N2026

Etiologies / facteurs déclenchants :

- Infestation parasitaire, hépatite virale, médicaments, froid, effort, aliments, infections
- **▲ ▲ L'urticaire chronique (> 6 semaines) est le plus souvent idiopathique**

 Vu : N2022

[RANG 23] LEPRE

Pr. Aboudourib • ~0.18 Q/examen

📖 📖 Ref : CEDEF • OMS – lepre (*Mycobacterium leprae*)

🔒 Correction officielle normal 2021 (e-qe.online) : [Ouvrir le cours officiel ↗](#)

Lepre lepromateuse (multibacillaire) :

- > 20 lésions, topographie SYMETRIQUE bilaterale, facies LEONIN, madarose (alopecie des queues des sourcils), tres contagieuse
- ⚠ ⚠ *N'atteint pas electivement l'enfant ; atteinte neurologique symetrique/tardive (severe asymetrique = tuberculoide/borderline)*

📖 Vu : N2021

Formes tuberculoide & borderline :

- Tuberculoide (paucibacillaire) : peu de lésions hypochromiques anesthesiques a limites nettes, atteinte nerveuse severe asymetrique
- Borderline-borderline : lésions annulaires, intermediaires
- ⚠ ⚠ *Les plaques infiltrées anesthesiques a limites nettes orientent vers une forme tuberculoide*

📖 Vu : N2019

PARTIE 4 – TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER – À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé – NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK – BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~1.1% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

Topics hors programme 2026 (par fréquence décroissante) :

Topic (hors programme)	Total	Moy/exam
HTA endocriniennes (HTA secondaire d'origine endocrinienne)	6 Q	0.55

[HORS 1] HTA ENDOCRINIENNES

6 questions – 0.55 Q/examen (apparue jusqu'en 2026) – HORS liste 2025-26

Quand suspecter une HTA secondaire :

- Age JEUNE de survenue (< 30 ans), HTA SEVERE d'emblée, HTA RESISTANTE (tri/quadrithérapie), hypokaliémie, symptômes paroxystiques
- ⚠ ⚠ Ni le sexe, ni le simple besoin d'un IEC ne sont des arguments

📖 Vu : N2022, N2026

Causes endocriniennes d'HTA :

- Acromégalie, syndrome de Cushing, hyperaldostéronisme primaire (Conn), pheochromocytome ; dysthyroïdies
- ⚠ ⚠ Cushing et acromégalie sont au programme (leçons dédiées) ; Conn et pheochromocytome ne le sont pas en 2025-26

📖 Vu : N2022

Hyperaldostéronisme primaire (Conn) & pheochromocytome :

- Conn : HTA + HYPOKALIEMIE profonde ; aldostérone ELEVEE + renine BASSE (rapport élevé) ; causes : hyperplasie bilatérale, adénome de Conn
- Pheochromocytome : diagnostic = METANEPHRINES (dérivés méthoxyles) URINAIRES ; triade céphalées-sueurs-palpitations + HTA paroxystique
- ⚠ ⚠ Pheochromocytome : pas le dosage d'adrénaline plasmatique de 8h ni le CLU

📖 Vu : N2022

AIDE-MÉMOIRE FINAL – HIGH-YIELD CONCOURS DERMATOLOGIE & ENDOCRINOLOGIE

** CLASSIFICATIONS & SEUILS A MEMORISER **

Diabete	GAJ $\geq 1,26$ g/l · gly aleatoire ≥ 2 · HbA1c $\geq 6,5$ %
Prediabete	GAJ 1,10-1,25 · HbA1c 5,7-6,4 % · HGP0-2h 1,40-1,99
Diabete gestationnel	GAJ $\geq 0,92$ g/l (HGP0 75g, 24-28 SA)
Adenome hypophysaire	Micro < 10 mm · Macro ≥ 10 mm (IRM)
Obesite (IMC)	Surpoids 25-30 · Moderee 30-35 · Severe 35-40 · Morbide ≥ 40
Tour de taille (androide)	Femme > 80 cm · Homme > 94 cm
Nodule thyroïdien	EU-TIRADS · cancer ≈ 5 % · cytoponction T5 >5 mm / T4 >10 mm / T3 >20 mm
Lyell / SJS	NET (Lyell) > 30 % · SJS < 10 % · overlap 10-30 %
Index / charge glycémique	IG bas < 55 , eleve > 70 · CG = IG x g/100 (bas ≤ 10 , eleve ≥ 20)
Calories des macronutriments	Glucides 4 · Proteines 4 · Lipides 9 kcal/g

** LE BON EXAMEN AU BON MOMENT – TESTS & MARQUEURS CLES **

Marqueur / Critère	Indication
IRM hypophysaire	Examen de reference de l'adenome hypophysaire
ACTH plasmatique	Cushing confirme $\rightarrow$ localisation : ACTH haut/N = dependant ; ACTH bas = surrenalien
CLU/24h + cortisol minuit + freinage minute	Confirment l'hypercorticisme ($\neq$ cortisol de 8h)
ACTH eleve + cortisol 8h bas	Insuffisance surrenalienne peripherique (Addison)
Synacthene / hypoglycémie insulínique	Insuffisance surrenale si cortisol 8h non franchement bas
GH non freinee sous HGPO + IGF-1	Diagnostic de l'acromegalie
Prolactinémie de base (1 dosage)	Hyperprolactinémie ($\neq$ test TRH)
Couple TSH / LT4 (puis LT3)	Diagnostic de thyrotoxicose
Ac anti-recepteurs TSH + Thyroid inferno	Maladie de Basedow

Marqueur / Critère	Indication
Scinti I123 : hyperfixation localisee + extinction	Nodule chaud toxique
Aldosterone elevee / renine basse	Hyperaldosteronisme primaire (Conn)
Metanephrrines urinaires	Pheochromocytome
TPHA (specifique) / VDRL (suivi, non specifique)	Syphilis – VDRL+ / TPHA- = FAUX positif
Charge virale VIH	Primo-infection VIH (Western blot encore negatif)
Histo bulle + IFD peri-lesionnelle	Dermatoses bulleuses auto-immunes
Lampe de Wood : VERT	Teigne microsporique (trichophytique = Wood negatif)
Lampe de Wood : ROUGE corail	Erythrasma (Corynebacterium)
Test au monofilament (10 g)	Depistage de la neuropathie diabetique

**** PIEGES CLASSIQUES DU CONCOURS (les FAUX qui font perdre des points) ****

- ▲ Prolactinome (meme macro) → traitement MEDICAL (agonistes dopaminergiques), JAMAIS chirurgie en 1re intention
- ▲ VDRL+ / TPHA- = FAUX POSITIF (pas une syphilis latente) ; chez la femme enceinte a examen normal → rassurer
- ▲ Maladie d'Addison & insuffisance cardiaque ne sont PAS des causes de diabete secondaire
- ▲ Pan-hypopituitarisme = hypothyroidie CENTRALE (pas peripherique)
- ▲ La CREPITATION dans une dermo-hypodermite = fasciite necrosante (jamais dans l'erysipele simple) ; AINS interdits
- ▲ Cortisol de 8h SEUL ne confirme jamais un Cushing (rythme circadien)
- ▲ Pemphigus = INTRA-epidermique / Nikolsky+ ; Pemphigoide = SOUS-epidermique / Nikolsky- / sujet age
- ▲ Keratoses actiniques → carcinome EPIDERMOIDE (pas CBC, pas melanome) ; keratose seborrheique = benigne
- ▲ Melanome = malignite GENERALE (metastase) ; au Maroc siege plantaire ; atteint les ongles
- ▲ Acne purement retentionnelle (microkystes/comedons) → retinoide topique SEUL (pas de cyclines)
- ▲ Beta-bloquants, antipaludeens et IEC AGGRAVENT le psoriasis ; methotrexate/ciclosporine le TRAITENT
- ▲ Eczema de contact = hypersensibilite RETARDEE type IV (nickel) ; pas une allergie IgE
- ▲ Vitamine C = HYDROSOLUBLE ; liposolubles = A, D, E, K
- ▲ Insulinoresistance ne concerne PAS la medullosurrenale/cerveau ; au foie elle AUGMENTE la neoglucogenese

- ▲ Le traitement preventif de l'herpes : > 6 recurrences/an (pas > 3), non contre-indique chez la femme enceinte
- ▲ Addison : regime NORMOSALE + hydrocortisone + fludrocortisone (jamais de potassium per os : deja hyperkaliemie)

**** ARBRES DECISIONNELS & ENCHAINEMENTS CLES ****

- Hypercorticisme : CONFIRMER (CLU/24h + cortisol minuit + freinage minute) → LOCALISER (ACTH) → ACTH haut = corticotrope/ectopique (IRM hypophyse + TDM thorax) · ACTH bas = surrenalien (TDM surrenales)
- Adenome hypophysaire : IRM → taille (micro/macro) → bilan hormonal → si prolactinome = agonistes dopa · si Cushing/acromegalie/compressif = chirurgie
- Glycemie elevee a l'admission (SCA/IDM) → reevaluer a distance : normalisation = stress/HMJ/IGT · HbA1c ≥ 6,5 % = diabete revele
- Thyrotoxicose : couple TSH/LT4 (dg positif) → etiologie : anti-RTSH + Doppler (Basedow) · scintigraphie (nodule chaud)
- Nodule thyroïdien : echo + EU-TIRADS + TSH → TSH basse = scintigraphie · cytoponction selon score x taille
- Ulceration genitale : INDOLORE induree = syphilis (TPHA-VDRL) · DOULOUREUSE purulente = chancre mou · recidivante = herpes/aphte/EPF
- Dermo-hypodermite de jambe : fièvre + placard + porte d'entree = erysipele (penicilline G) ; douleur/necrose/crepitation = fasciite (urgence chirurgicale)
- Bulles : FLASQUES + muqueuses + Nikolsky+ = pemphigus · TENDUES + prurit + sujet age + Nikolsky- = pemphigoïde (dermocorticoides) · faces d'extension + IgA = dermatite herpetiforme (disulfone)
- Pied diabetique : neuropathie + arteriopathie + microtrauma + infection → ulcere indolore (neuro) vs douloureux/necrose (arteritique)

Généré par Claude.ai (claude-opus-4.x) – Version 1

Cross-match 550 QEs officielles × Cours AIO Dermato + Endocrino 2026 · Corrections officielles e-qe.online

Endocrino : Pr Elmgari · Pr Ansari · Pr Baizri – Dermato : Pr Bouhamidi · Pr Amal · Pr Aboudourib · Pr Hocar – FMPM 2025-26

Améliorations Version 1 :

- ✓ 550 QE de 11 sessions FMPM (2019 → normal 2026) analysees, dedupliques et classees par frequence
- ✓ Lecons fusionnees intelligemment (axe corticotrope, eczema, IST) selon la liste officielle 2025-26
- ✓ PARTIE 3 strictement par rang ; FAUX explicites avec ▲ (le plus haut rendement pour le concours)
- ✓ Liens cliquables vers les corrections officielles e-qe.online par session
- ✓ HTA endocrinienne placee en PARTIE 4 (hors liste 2025-26) avec disclaimer
- ✓ Aide-memoire transversal : seuils, le bon examen au bon moment, pieges, arbres decisionnels